

【数字評価スケール (Numerical Rating Scale : NRS)】



『痛み (NRS) : 3/10』と表記する

【視覚的アナログ評価スケール (Visual Analogue Scale : VAS)】



『/』で直接表記する

図1 がん疼痛評価ツール

る。予測できない痛みの代表は、定時鎮痛薬の切れ目に生じる痛みである。

3 がん疼痛の評価

がん疼痛を含む痛みは、病歴聴取、診察、検査結果などを参考に、その原因の評価と痛みの特徴の評価の2本立てで包括的に行う。痛みの原因の評価にて、前述のがん疼痛と判断された場合、痛みの特徴の評価は、日常生活への影響、痛みのパターン、痛みの強さ、痛みの部位、痛みの経過、痛みの性状、痛みの増悪・軽快因子、定時鎮痛薬治療の効果、鎮痛薬レスキュー・ドーズへの反応と治療の副作用について分けて行う。最近では、患者自身により主観的な症状の直接評価を行う患者報告アウトカム (patient reported outcome) の有効性が明らかになっている⁴⁾。実際の臨床においても、痛みに関するアセスメントツール (評価シート) を用いて痛みを評価するのが一般的である (図1)。

4 がん疼痛に対する薬物療法

がん疼痛の治療は包括的評価に基づいて行われる。原因の評価で原因に応じた対応が必要な場合は、そちらが優先される。具体的な例としては、脊椎転移による痛みが脊髄横断症候群のような重篤な病態の初期サインである場合は、痛みの治療は開始されるものの、その効果の評価などより病態そのものへの治療 (除圧手術や放射線療法) が優先される。原因の評価でがん疼痛であり臨床症候群に合致しない場合は、共通する疼痛治療を行う。

a WHO がん疼痛ガイドライン

WHO がん疼痛ガイドラインは7つの原則が明記されている。①治療の目標：がん疼痛治療の目標は「患者にとって許容可能な生活の質を維持できるレベルまで痛みを軽減する」ことである。②包括的評価：疼痛治療前と治療中に、必ず痛みの包括的評価を行う。③

安全性の保障：オピオイドの適切で効果的な管理は患者の安全の確保と薬物の社会への転用リスクを減らすために不可欠である。④包括的がん疼痛マネジメント：疼痛に対する薬物療法ががん疼痛緩和の主体である一方で、心理社会的ケアなど包括的なケアも重要である。⑤オピオイド使用の平等性：オピオイドはすべての国で使用できる必要がある。⑥鎮痛薬：鎮痛薬使用にあたっては、i 経口的に (by mouth), ii 時刻を決めて規則正しく (by the clock), iii 患者ごとの個別的な量で (for the individual), iv そのうえで細かい配慮を (with attention to detail) の4つの基本的な使用法を掲げている³⁾。

b 非オピオイド鎮痛薬

非オピオイド鎮痛薬には、非ステロイド抗炎症薬 (NSAIDs) と acetaminophen が含まれる。NSAIDs は抗炎症作用を有しアラキドン酸代謝経路での発痛物質産生を抑制することで鎮痛作用を発揮する。acetaminophen の抗炎症作用は弱い有害事象が少なく、NSAIDs を投与しにくい患者においても使用しやすい利点がある。

c オピオイド

オピオイド (opioid) とは、オピオイド受容体に作用する麻薬性鎮痛薬やその関連合成鎮痛薬、内因性ペプチド類の総称である。がん疼痛治療に用いられるオピオイドは表2の通り種類が多く、その鎮痛効果や有害事象のプロファイルには臨床的に有意な差がある。症状の強さと有害事象のバランスがとれないときには、内服投与から静脈内投与へ変えるなど、投与経路の変更でバランスをとることが可能となる場合がある。それでもバランスがとれない場合、オピオイド間の効果や有害事象の差を利用して、患者にとってより最適なオピオイドに変更する戦略をオピオイドスイッチングと呼ぶ。

d 鎮痛補助薬

主体的な鎮痛薬理作用は有さないが、鎮痛薬と併用